AsistIA · Guion del pitch final (v7)

Unos 4:25 min + margen · 11 diapositivas + anexo · 2 escenas · Equipo Algorritmia · CientíficaHack 2026

1. Estructura y reparto

Bloque	Diap.	Tiempo	Quién
Gancho + saludo	1–2	0:00–0:20	Orador 1 (Hideki)
Problema (máx. 40 s)	3–4	0:20–1:00	Orador 1
Solución + QR + simulación	5	1:00–1:25	Orador 1 · Compañero 4 reparte los QR
Escena 1 · Tito en el hospital	6	1:25–2:00	Narrador (Angel) · Tito (Compañero 3) · voz de IA
Clínicas: la espera con cita	7	2:00–2:20	Narrador
Escena 2 · Preconsulta con IA	8	2:20–2:55	Narrador · Tito · animación en pantalla
Cinco etapas: hospital y clínica	9	2:55–3:30	Orador 1
Modelo de negocio	10	3:30–4:10	Angel (CFO)
Cierre	11	4:10–4:25	Orador 1

Quedan unos 35 segundos de margen para entradas, aplausos y cambios de pantalla. El reparto es una sugerencia; ajústenlo a su equipo.

Antes de subir:

- ☐ Pegar el QR en la diapositiva 5 e imprimir los QR que se repartirán.
- ☐ Completar los dos nombres del equipo en la diapositiva 11.
- ☐ Probar la voz de IA por los parlantes del auditorio. Tener el audio de la llamada grabado como respaldo.
- ☐ Disfraz y accesorios de Tito: un ticket de cita, un celular básico y una venda o rodillera para la escena 2.
- ☐ Instalar DM Serif Display y DM Sans o presentar el PDF (el PDF no tiene animaciones).
- ☐ **Animaciones automáticas:**
    - Diapositiva 6: las franjas “Sin AsistIA” y “Con AsistIA” aparecen solas a los 9 y 18 segundos.
    - Diapositiva 8: el chat avanza solo cada 2.4 segundos y termina a los 26.
    - Ensayen la escena con ese ritmo.

2. Guion palabra por palabra

Diap.	Tiempo	Qué decir	Acción
1 Gancho	0:00–0:15	“En un solo hospital de Lima se pierden **347 citas al día**: el paciente no llega y el cupo queda vacío. Y en ese mismo hospital hay personas haciendo cola desde las cinco de la mañana para conseguir una. *(pausa)* ¿Cómo es posible?”	Entrar en silencio. Decir el número antes de saludar
2 Portada	0:15–0:20	“Buenos días, somos Algorritmia, y esto es AsistIA.”	Sonreír y pasar rápido
3 Cifras	0:20–0:48	“Y no es un caso aislado. En el María Auxiliadora se pierde **una de cada cuatro citas**: 106,100 en un año. Quien sí consigue cita espera una mediana de **17 días**. En emergencia, la Contraloría encontró pacientes con más de 12 horas en observación en **tres de cada cuatro** hospitales que supervisó en Lima. SUSALUD suma 33 mil reclamos por demora y casi 37 mil por falta de información. Y no es solo el Estado: la clínica del jurado nos contó de retrasos de horas.”	Las cifras aparecen una por una
4 Conclusión	0:48–1:00	“Si juntamos todo, el problema no es solo que falten médicos. **Es que el recorrido del paciente no se coordina**: se pierden cupos mientras otros esperan, nadie sabe en qué etapa se forma la espera… y eso lo paga el paciente, con su tiempo y con su salud.”	Bajar la voz en la última frase
5 Solución	1:00–1:25	“AsistIA coordina cada paso del paciente. **Confirma** la cita por mensaje o por voz. Si alguien no podrá ir, **reasigna** ese cupo a quien más lo necesita. Y **mide** en qué etapa se forma la espera. Mi compañero les está entregando un QR: con él, ustedes son Carmen. Aquí lo ven: Carmen avisa que no podrá ir… y su cupo no se pierde.”	El compañero 4 reparte los QR mientras habla. El teléfono se anima solo
6 Escena 1	1:25–2:00	Ver la sección 3.	Entra Tito
7 Clínicas	2:00–2:20	“Pero no todos necesitamos un hospital. En una clínica reservamos por la app, llegamos puntuales a las diez… y nos atienden a las once y veinte, porque el consultorio sigue lleno. AsistIA primero reduce que esto pase: confirma las citas y llena los huecos. Y además mide cuánto está durando cada consulta hoy: horas antes, te da una **ventana de llegada** para que esperes lo menos posible. Y tiene algo más: la preconsulta con IA.”	Señalar la notificación
8 Escena 2	2:20–2:55	Ver la sección 4.	Tito vuelve con rodillera
9 5 etapas	2:55–3:30	“Todo esto funciona en cinco etapas: antes de la cita, llegada y triaje, espera, atención y alta, y cupos liberados. **En un hospital**, lo clave es llegar a quien no usa smartphone, alertar al responsable cuando alguien espera demasiado y que cada cupo vaya a quien más lo necesita. **En una clínica**, lo clave es la experiencia: preconsulta, ventana de llegada y agenda llena. Y debajo, un tablero mide cada etapa, como el rastreo de un envío.”	Fila de hospital y luego fila de clínica

Diap.	Tiempo	Qué decir	Acción
10 Negocio	3:30–4:10	"¿Cómo ganamos? Primero se prueba: **ocho semanas gratis**, con metas acordadas. Después, una suscripción fija por sede según el tamaño de su agenda: **600 soles** una clínica, hasta **2,900** un hospital grande. Los mensajes y la voz se pagan al costo, a nombre del cliente. ¿Y cuánto gana el cliente? Si recupera el 10 % de sus citas perdidas, un hospital como el HMA recupera unos **14,800 soles al mes** por encima de lo que paga; una clínica, unos **970**. Y a nosotros nos basta con **dos hospitales, o uno y cuatro clínicas**, para ser rentables."	Planes, luego barras, luego la franja de AsistIA
11 Cierre	4:10–4:25	"Con un 10 % de citas recuperadas, son **10,600 consultas más al año** en un solo hospital, con los mismos médicos. Primero medimos dónde se forma la espera; después, con ustedes, probamos qué funciona. Somos Algorritmia. Gracias."	Todo el equipo al frente. Silencio

Gancho alternativo, con interacción (la rúbrica da 20 puntos a la interacción): "Levante la mano quien haya tenido cita… y aun así haya esperado más de una hora para que lo atiendan. *(pausa)* Ahora imaginen que, en el mismo hospital, se pierden 347 citas al día." Luego se sigue igual.

3. Escena 1 · Tito en el hospital (unos 35 s)

Tito tiene 62 años, necesita una consulta de oncología y no usa WhatsApp.

Quién	Qué dice o hace
Narrador	"Él es Tito. Tiene 62 años y su médico le pidió una consulta de oncología cuanto antes."
Tito	*(entra con un ticket, lo lee y se agarra la cabeza)* "¿Cinco semanas? ¡Me dieron cita para dentro de cinco semanas!"
Narrador	"Sin AsistIA, Tito espera. Y en cáncer, cada semana cuenta. Pero hoy, una paciente avisó que no podrá ir a su cita." *(aparece la franja roja)*
Sonido	*Suena el celular de Tito; la voz de IA sale por los parlantes.*
Voz de IA	"Buenos días, Tito. Le habla el asistente automatizado del hospital. Se liberó un cupo de oncología para mañana a las 9:00. ¿Desea tomarlo?"
Tito	"¡Sí, sí lo quiero!"
Voz de IA	"Listo. Su cita quedó reservada para mañana a las 9:00." *(aparece la franja verde)*
Narrador	"Tito no usa WhatsApp, por eso AsistIA lo llamó. Y el cupo le llegó porque el personal lo priorizó por su condición clínica."

Por qué está escrita así:

- **No dice "Tito moriría".** El jurado incluye médicos, y la propuesta no promete reducir la espera. "En cáncer, cada semana cuenta" transmite el mismo dolor sin prometer de más.
- **"Un par de horas" es el tiempo hasta reservar el cupo liberado, no hasta ser atendido.** Así coincide con la lista de espera de la propuesta.
- **La prioridad la pone un profesional**, no la IA. Si preguntan, ver la pregunta N2.

4. Escena 2 · Preconsulta en la clínica (unos 35 s)

Quién	Qué dice o hace
Narrador	“Tito ya está en tratamiento. Hoy le duele la rodilla y reservó en una clínica.”
Pantalla: IA	“Hola, Tito. Antes de su cita, ¿qué molestia quiere consultar?”
Tito	*(con rodillera, mirando su celular)* “Me duele la rodilla derecha desde hace una semana.”
Pantalla	Se llena **Motivo** en el resumen.
Pantalla: IA	“¿Tomó algún medicamento? ¿Tiene alergias?”
Tito	“Ibuprofeno. Alergias, ninguna.”
Pantalla: IA	“¿Tiene fiebre, o la rodilla está muy hinchada o caliente?”
Tito	“No.”
Pantalla: IA	“Gracias, Tito. Su médico lo recibirá con este resumen. Su consultorio va con 20 min de atraso: llegue entre 10:20 y 10:35.”
Narrador	“El médico recibe este resumen antes de verlo, marcado como ‘referido por el paciente’. No diagnostica: si Tito hubiera tenido fiebre, lo derivaba a emergencia.”

Notas:

- **Quién lee las preguntas de la IA:** el narrador, o la voz de IA de la app si la preconsulta tiene voz. Tito solo responde.
- **Ritmo:** cada mensaje aparece a los 2.4 s. Tito responde en cuanto ve su burbuja.
- **La palabra clave es “consulta más corta”, no “menos espera”.** El ensayo acortó la consulta un 28.7 %, pero no cambió la espera. Que el consultorio se atrase menos es lo que mide el piloto.

5. Reglas para hablar

Siempre decir:

- “Cada cupo, a quien más lo necesita.”
- “Consultas netas.”
- “Lo medimos en el piloto.”
- “Lo acordamos con la institución.”

Nunca decir:

- “Reducimos la espera X %.”
- “La IA diagnostica” o “la IA prioriza”.
- “Te atienden inmediatamente”: decir “esperas lo menos posible”.
- “Tito se salvó gracias a AsistIA”.
- “Recuperamos el 10 %” como un hecho: es un escenario.

Cifras para memorizar

Dato	Cifra
Gancho	347 citas perdidas al día en el HMA · colas desde las 5:00 a. m. (Defensoría)

Dato	Cifra
Problema	1 de 4 citas (106,100) · mediana de 17 días · 75 % de 16 hospitales con más de 12 h · 33,086 reclamos por demora y 36,895 por falta de información
Preconsulta	consulta 28.7 % más corta (ensayo PreA, 2,069 pacientes); la espera no cambió · 42 % de los resúmenes de GPT-4 con alguna alucinación
Planes	gratis 8 semanas · S/ 600 · 1,500 · 2,900 por sede al mes
Ganancia del cliente (escenario 10 %)	HMA: paga S/ 16,119 y recupera S/ 30,940 (+S/ 14,800) · clínica: paga S/ 1,667 y recupera S/ 2,640 (+S/ 970)
Equilibrio	HMA 461 consultas (5.2 %) · clínica 42 (6.3 %)
AsistIA	margen de S/ 2,150 por sede grande y S/ 294 por pequeña · rentable con 2 hospitales, o 1 hospital y 4 clínicas

6. Preguntas nuevas por las escenas

N1. ¿Cómo calculan la ventana de llegada? ¿Y si el médico se adelanta? “Con lo que ya registra la clínica: la hora real de inicio y fin de cada consulta del día. Se recalcula cada vez que termina una consulta y se avisa por rango, no por hora exacta. Mostramos una ventana conservadora, para que el paciente no llegue tarde si el médico se adelanta. Su precisión es una métrica del piloto.”

N2. ¿Cómo sabe AsistIA que Tito tiene cáncer o que es prioritario? “No lo sabe. La categoría clínica la asigna un profesional en la derivación. AsistIA solo ordena la lista con esa categoría y con el tiempo que ya lleva esperando, y sin la aprobación del personal no sale ninguna oferta.”

N3. ¿Y si no se libera ningún cupo para Tito? “Entonces Tito mantiene su cita: AsistIA no crea cupos, recupera los que hoy se pierden. Solo en el HMA son 347 al día; por eso hay de dónde sacar.”

N4. ¿Informarle al paciente su tiempo de espera mejora su experiencia? “Un ensayo con 1,011 pacientes no encontró mejoras en la satisfacción al informar el tiempo estimado. Por eso la ventana no busca solo informar: busca que el paciente pase menos tiempo en la sala. Eso es lo que medimos.”

N5. ¿La preconsulta reduce la espera? “La evidencia dice que acorta la consulta, un 28.7 % en un ensayo con 2,069 pacientes, pero no midió menos espera. Nuestra hipótesis es que consultas más cortas atrasan menos el consultorio, y la medimos en el piloto.”

N6. ¿Quién paga la voz de IA en un hospital público? “El hospital la paga al costo a su proveedor, porque las llamadas salen de su número y él es el titular de los datos. Solo se llama a quien no usa mensajería o al 10 % de mayor riesgo, así que el volumen es acotado.”

7. Banco de preguntas sobre la propuesta

Ordenadas por probabilidad. Las respuestas son cortas a propósito: unos 20 segundos. Entre paréntesis está la sección de la propuesta que las respalda.

Muy probables

1. ¿Ya lo probaron con pacientes reales? “Todavía no. Lo que viene de datos reales es la inasistencia del HMA y el desempeño del modelo, probado con meses que no vio durante el entrenamiento. El prototipo usa pacientes ficticios. La eficacia la dará el piloto de 8 semanas con grupo de comparación.” (3.7, 8.1)

2. ¿Por qué no prometen reducir la espera? “Porque hoy nadie la mide por etapas. Una revisión de 102 estudios muestra que la saturación tiene causas en la entrada, en el proceso y en la salida. Primero mostramos dónde se forma la espera; después probamos mejoras con umbrales acordados.” (2.3)

3. ¿Por qué una clínica pagaría? “Porque primero lo prueba gratis durante 8 semanas y paga solo si supera los umbrales que acordamos. A tarifa de aseguradora, cubre su costo total con 42 consultas netas al mes. Además obtiene lo que hoy no tiene: dónde se forma la espera en urgencias y su inasistencia real. Si contamos solo su margen, necesitaría unas 84 consultas; por eso el caso se arma con sus datos.” (10.1, 10.2)

4. ¿La preconsulta no es un diagnóstico encubierto? “No. No sugiere diagnósticos ni exámenes: ordena lo que el paciente refiere, y un signo de alarma interrumpe la entrevista y deriva a emergencia. Aun así no la declaramos exenta: la Ley 29459 incluye a los aplicativos según su finalidad, y la consultaremos con DIGEMID antes de usarla con pacientes.” (4.1, 4.3)

5. ¿Y si el resumen se equivoca? “Va a pasar: en un estudio de UCSF, el 42 % de los resúmenes de GPT-4 tuvo alguna alucinación. Por eso hay campos obligatorios, los datos ausentes se muestran como ‘no informado’, se verifican las negaciones y los medicamentos se confirman uno por uno. El médico corrige y la corrección queda registrada. La fidelidad del resumen es un resultado principal del piloto.” (4.2)

6. ¿Cómo se conecta con nuestro sistema? “Sobre el que ya tienen. Empezamos con una exportación diaria de la agenda, en modo observación, y luego pasamos a conectores. Los eventos se describen en HL7 FHIR R4 y nunca escribimos en el RENHICE ni en sus tablas.” (6.3)

7. ¿Desvían pacientes de emergencia? “No. AsistIA no interviene antes del triaje, que siempre hace un profesional. Solo después de que un médico determina que no hay emergencia se puede ofrecer, de forma voluntaria, un cupo en consulta. Si el paciente lo rechaza, se le sigue atendiendo.” (3.2, 3.4)

Probables

8. Un AUC de 0.655 es bajo. “Es moderado, y por eso no decide nada importante: todos reciben el mensaje y el modelo solo elige a quién llamar. Aun así, en su lista falta el 52 % frente al 27 % promedio. Si llamar sirve se mide con comparación, como en Chile, donde la inasistencia bajó de 21.0 % a 10.7 %.” (8.1)

9. El 40 % de las llamadas va a pacientes sin seguro. ¿No discrimina? “La llamada es un apoyo, no una sanción: nunca cancela una cita. La lista de espera nunca usa el seguro, el sexo ni el historial. Auditamos el AUC por grupo, que va de 0.59 a 0.66, y los resultados por grupo.” (5)

10. ¿Qué es una consulta neta? “Una atención que no habría ocurrido sin la oferta. Si solo se adelanta una cita que igual iba a ocurrir, no la contamos.” (3.5)

11. ¿Por qué dar el cupo al de mayor prioridad y no al primero que acepta? “Para no favorecer a quien responde más rápido, que suele ser joven y digital. Como esa regla no está validada, el piloto compara las dos en tiempo de llenado, consultas realizadas y diferencias por edad y canal.” (3.5)

12. ¿Las alertas no saturan al personal? “Por eso primero se diseña el circuito con la institución: un responsable por turno y escalamiento al jefe de guardia. Medimos cuántas alertas se generan, cuántas se atienden a tiempo y cuánto trabajo añaden. Y no hay botón de autoaviso para el paciente.” (3.3)

13. ¿Y quien no tiene WhatsApp ni smartphone? “Lo llama el agente de voz, y siempre existe la atención presencial. La voz es una opción, no un paso obligatorio.” (4.3, 5)

14. ¿El HMA está en la red interconectada? “Todavía no. La marcha blanca empezó en Dos de Mayo, Lima Este–Vitarte, Hipólito Unanue y San Bartolomé. El HMA entra en la fase 2 por exportación diaria.” (6.1, 7)

Difíciles

15. ¿Los datos salen del Perú? “En el prototipo, la nube y la voz operan fuera del país. El establecimiento es el responsable y AsistIA la encargada: antes del piloto se fijan por escrito los países, la retención, la prohibición de usar los datos para entrenar modelos y la respuesta a incidentes. Si la institución lo exige, alojamos en la infraestructura que apruebe. Ya cotizamos servidores propios en Lima: desde unos 29,000 minutos de voz al mes, salen más baratos que la API.” (13.1)

16. Si el hospital paga mensajes y voz aparte, ¿no es fraccionamiento? “La suscripción anual por sede queda por debajo de 8 UIT, pero la vía de contratación la define cada entidad según la Ley 32069. No separamos servicios para evitar un procedimiento de selección.” (10.1)

17. ¿Cómo gana dinero AsistIA? “Una sede grande nos deja unos S/ 2,150 al mes y una pequeña, unos S/ 294. Los costos fijos son de S/ 2,000, así que nos sostenemos con dos hospitales, o con uno y cuatro clínicas. Los premios financian los pilotos gratuitos.” (10.3)

18. ¿En qué se diferencian de HEVES, AgendaPro o Fast Pass? “Ninguna pieza es nueva, y no lo decimos. La diferencia está en cuatro decisiones: medir por etapas antes de intervenir, el mismo núcleo para hospitales y clínicas, voz para quien no usa smartphone y cupos asignados con reglas clínicas auditables, que comparamos contra ‘el primero que acepta’.” (8.3)

19. ¿Por qué 25.7 % si con todas las especialidades sale 31.9 %? “Excluimos 19 especialidades con 95 % o más de inasistencia; en 18 marcaba 100 %, lo que indica que ahí no se registra la asistencia. Usamos la cifra conservadora y la validaremos con el hospital.” (2.1)

20. ¿Quién registra las horas en urgencias? Nadie tiene tiempo. “Empezamos con los 3 o 4 eventos que la institución ya registra y medimos la completitud por recorrido. Si seis eventos se registraran cada uno el 90 % de las veces, solo la mitad de los recorridos quedaría completa: por eso empezamos con pocos.” (3.6)

21. ¿Y si alguien usa la llamada para estafar? “El agente se presenta como asistente automatizado, llama siempre desde el mismo número y nunca pide pagos, claves ni el DNI completo, y lo dice en la llamada. Si el paciente lo pide, transfiere a una persona.” (4.3)

22. ¿Informarle al paciente en qué etapa está mejora su experiencia? “Un ensayo con 1,011 pacientes no encontró mejoras en la satisfacción. Por eso es opcional, y nuestro foco es que el personal

vea y actúe.” (3.3)

Puentes para cuando no se sabe la respuesta:

- “Buena observación. Es justo lo que el piloto mide; lo acordaríamos con ustedes como umbral.”
- “No tenemos ese dato y preferimos no inventarlo. Lo que sí sabemos es…”

8. Coherencia con la propuesta v5.1

1. **La ventana de llegada no está en la propuesta v5.1.** Preséntenla como una función para clínicas que se valida en el piloto, sin prometer “atención inmediata”. Si el prototipo no la tiene, muéstrenla solo en las diapositivas 7 y 8.
2. **Las demás cifras del PPT salen de la propuesta.** No agreguen números en vivo.
3. **El anexo (diapositivas 13 a 20)** es para responder preguntas: tablero, confirmación y modelo, preconsulta, lista de espera, implementación, seguridad, negocio detallado e impacto.